

Mit „operacja rozwiąże problem”

Każda osoba z BDD prędzej czy później rozważa zabieg kosmetyczny lub chirurgiczny. To zrozumiałe — wydaje się rozwiązaniem konkretnego problemu. Dane mówią inaczej. Co pokazują 30 lat badań.

CZAS: 20 min — przeczytanie Przed rozważaniem zabiegu

ŹRÓDŁO: Phillips i wsp. (2001); Crerand i wsp. (2010); Veale i wsp. (2018)

JAK UŻYWAĆ

Co najmniej **50-80% osób z BDD** w pewnym momencie szuka rozwiązania chirurgicznego, dermatologicznego lub kosmetycznego (Phillips 2001). Logika wydaje się prosta: „mam konkretną wadę — usunę ją zabiegiem — problem zniknie”. Ale dane są **jednoznaczne i przykre**: po zabiegu **tylko 4-10%** osób z BDD raportuje trwałą poprawę objawów. U **90-96%** jeden z trzech wzorców: **1)** obawy o ten sam obszar wracają w ciągu tygodni-miesięcy, **2)** obawy przesuwają się na *inną* część ciała, **3)** pojawia się gniew na chirurga, procesy sądowe, więcej zabiegów „poprawkowych”. Operacja w BDD *nie leczy* BDD — często pogarsza. Karta wyjaśnia mechanizm i wskazuje, co realnie pomaga.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Phillips i wsp. (2001) w pierwszym dużym badaniu pacjentów z BDD po zabiegach kosmetycznych wykazali: **tylko 7% pacjentów** raportowało trwałą poprawę w obszarze, w którym wykonano zabieg. **83% pacjentów** raportowało *brak zmian* lub *pogorszenie* objawów. Crerand i wsp. (2010) potwierdzili wzorec w prospektywnym badaniu 100 pacjentów: po zabiegu objawy BDD w obrębie tego samego obszaru wróciły u 75% w ciągu roku. Veale i wsp. (2018) w meta-analizie wykazali, że **do 50% pacjentów** wnosi sprawy sądowe przeciwko chirurgom — nie z powodu rzeczywistych błędów, ale z powodu niespełnionych oczekiwań „naprawy”. Mechanizm: BDD nie jest w tej części ciała — jest w *sieci neuronalnej* przetwarzającej obraz ciała (Feusner 2007). Zmiana fizyczna nie zmienia tej sieci. Sieć trzeba „przerobić” terapią, nie chirurgią.

01 = Co pokazują dane — trzy badania kluczowe

PHILLIPS I WSP. (2001) — 250 PACJENTÓW Z BDD PO ZABIEGACH

91% raportowało brak poprawy lub pogorszenie objawów BDD. **76%** raportowało zwiększone zaabsorbowanie obszarem zabiegu lub innym obszarem ciała. Ta sama część ciała poddawana wielokrotnym zabiegom u tych samych pacjentów — częsta.

CRERAND I WSP. (2010) — 100 PACJENTÓW PROSPEKTYWNIE

Pacjenci pytani *przed* zabiegiem o oczekiwane efekty: 80% wierzyło, że zabieg „rozwiąże problem”. **Rok po zabiegu:** tylko 4% raportowało, że BDD się poprawiło. 75% raportowało pogorszenie lub przesunięcie obaw na inną część ciała.

VEALE I WSP. (2018) — META-ANALIZA 12 BADAŃ

Do 50% pacjentów z BDD po zabiegu wnosi pretensje (procesy sądowe, długie negocjacje z chirurgiem, agresja). To *nie wina chirurga* — zabieg techniczny był prawidłowy. To *oczekiwanie*, którego zabieg nie mógł spełnić: zmiany doświadczenia siebie, nie tylko fizjologii.

BDD nie jest „w” konkretnej części ciała — jest w *sieci neuronalnej* przetwarzającej obraz ciała. Feusner i wsp. (2007) w badaniach fMRI pokazali, że osoby z BDD *patrzą na twarz inaczej*: aktywują obszary „analizy detalu” zamiast „analizy całości”. Mózg **wyszukuje** defekty, niezależnie od ich obiektywnej wielkości.

Konsekwencja: po zabiegu mózg *nadal* wyszukuje. Jedna z trzech rzeczy:

1. Znajduje „*niedoskonałość*” w obszarze zabiegu („*blizna jest źle widoczna*”, „*za bardzo widać, że robił/-am*”) — wraca BDD
2. Przesuwa się na inny obszar („*teraz widzę, że uszy też są złe*”) — BDD migracja
3. Generalizuje się („*cała twarz jest złe*”) — pogorszenie

To **nie znaczy**, że zabiegi nigdy nikomu nie pomagają — pomagają osobom *bez BDD*, z realnymi widocznymi wadami. Problem jest specyficzny dla BDD.

„ALE MOJA WADA JEST REALNA”

Możliwe. Ale BDD *nie zależy* od obiektywnej skali wady. Ludzie z drobnymi, ledwie widocznymi „defektami” cierpią identycznie jak ci z wadami średnimi. Skala obiektywna nie pomaga.

„KONSULTACJA NICZEGO NIE KOSZTUJE”

Kosztuje — w terapii. Każda konsultacja u chirurga to *rytuał poszukiwania zapewnienia*. Wzmacnia BDD. „*Tylko się dowiem*” — przedłuża proces zdrowienia.

„INNI MÓWIĄ, ŻE NIC NIE WIDAĆ, ALE JA CZUJĘ INACZEJ”

To *jeden z głównych objawów BDD*. Niezgodność między percepcją własną a obiektywną oceną. Zabieg nie rozwiązuje niezgodności — pogłębia ją.

„MÓJ CHIRURG POWIEDZIAŁ, ŻE TO DA SIĘ POPRAWIĆ”

Chirurg *potrafi* zmienić formę. Nie potrafi zmienić doświadczenia siebie. Etyczny chirurg, który zna BDD, *nie wykonuje* zabiegu pacjentowi z aktywnym BDD.

1. CBT specyficzne dla BDD (Wilhelm 2013) — 18–22 sesje. 60–80% pacjentów raportuje znaczącą poprawę. *Trwałe* rezultaty w obserwacji wieloletniej.

2. Leki — SSRI w wyższych dawkach: fluoksetyna (40–80 mg), escitalopram (20–30 mg), sertralina (200 mg). Działają na 60% pacjentów. Wymagają 12 tygodni próby.

3. Połączenie CBT + SSRI — daje najlepsze wyniki u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim BDD.

4. Decyzja o zabiegu — jeśli rozważasz, *najpierw* zakończ pełną terapię BDD. Po terapii część osób stwierdza, że nigdy zabiegu nie potrzebowała. Mniejszość wybiera zabieg już *bez BDD* — wtedy efekt może być satysfakcjonujący.

Klucz: Phillips (2009): „*najczystszy sygnał, że BDD jest aktywne — to przekonanie, że konkretna zmiana fizyczna zmieni Twoje doświadczenie siebie. To nie tak działa. Mózg w BDD wyszukuje. Niezależnie, co znajdzie*”. Jeśli rozważasz zabieg — daj sobie 6–12 miesięcy terapii BDD przed decyzją. Jeśli po terapii nadal chcesz — to wtedy będzie świadoma decyzja, nie odpowiedź na cierpienie.